Bronquiolite Viral Aguda
Material de estudo – Letícia

Semiologia e Semiotécnica · Sua parte: diagnóstico e tratamento (slides 11 e 12)

Sua parte na apresentação

- **Letícia:** slides 11 (Diagnóstico) e 12 (Tratamento), cerca de 2 minutos e meio.
- Antes de você: a Fabricia apresenta sinais e sintomas e sinais de alarme (slides 9 e 10). Depois de você: a Celma apresenta cuidados de enfermagem e anotação (slides 13 a 15).
- Frase de passagem para a Celma: "O tratamento diz o que o bebê precisa. Agora a Celma mostra como a enfermagem garante isso ao lado dele."
- A seção 4 (anotação de enfermagem) é da Celma, mas está aqui para você entender a parte dela e poder cobri-la se precisar.
- As siglas estão explicadas no glossário (seção 7). A principal fonte da sua parte é a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria): entidade científica dos pediatras do Brasil, que publica diretrizes baseadas em estudos. Tudo o que é "indicado" e "não indicado" no slide 12 vem da diretriz da SBP de 2017.

1. Resumo objetivo da doença

Tópico	O essencial
O que é	Infecção viral aguda que inflama os bronquíolos (vias aéreas com menos de 2 mm).
Quem pega	Crianças menores de 2 anos; mais grave em menores de 6 meses, prematuros, cardiopatas e com doença pulmonar crônica.
Causa	VSR (vírus sincicial respiratório) em até 75% dos casos. Outros: rinovírus, metapneumovírus, adenovírus, parainfluenza, influenza.
Transmissão	Gotículas, contato direto com secreções e superfícies. VSR dura menos de 1 h nas mãos e até cerca de 24 h em superfícies duras.
Incubação	4 a 5 dias.
Época	Sudeste: março a julho (SBP). MG: pico recente de fevereiro a abril (SES-MG).
O que acontece	Edema da parede + muco + restos de células = obstrução do bronquíolo, ar preso e queda da oxigenação.
Evolução	Começa como resfriado (dias 1–3), piora entre o 3º e o 5º dia e melhora em 7 a 10 dias; a tosse pode durar mais.
Prevenção no SUS	Vacina VSR para gestantes a partir da 28ª semana; nirsevimabe para prematuros e menores de 2 anos com comorbidades.

Frase para lembrar: bronquite atinge os brônquios (galhos grossos); bronquiolite atinge os bronquíolos (galhos finos). Como o bebê tem vias aéreas muito estreitas e respira quase só pelo nariz, qualquer inchaço ou muco já dificulta respirar e mamar.

2. Diagnóstico (aprofundado)

2.1 O diagnóstico é clínico

A SBP (2017) afirma que o diagnóstico da bronquiolite é principalmente clínico: baseia-se na história (idade, início com resfriado, contato com pessoas gripadas, época do ano) e no exame físico. Não existe um exame que "confirme" a bronquiolite sozinho.

2.2 O que se observa no exame físico

- **Inspeção:** coriza, tosse, respiração rápida, tiragem (subcostal, intercostal, de fúrcula), batimento de asa de nariz, cianose.
- **Contagem da frequência respiratória:** sempre por 1 minuto inteiro, com o bebê calmo, de preferência dormindo.
- **Ausculta (feita pelo médico/enfermeiro):** sibilos (chiado) e crepitações (estertores finos).
- **Estado geral:** ativo e reativo × hipoativo ou prostrado; aceitação das mamadas; diurese.

2.3 Exames complementares: quando usar

Exame	Uso na bronquiolite
Oximetria de pulso	Mede a SpO_2. Uso intermitente na fase aguda dos internados; o uso contínuo de rotina foi associado a internações mais longas (SBP).
Pesquisa viral (painel/teste rápido)	Não muda o tratamento, mas ajuda o hospital a organizar o isolamento (coorte) dos pacientes.
Raio-X de tórax	Não é rotina. Só se houver dúvida diagnóstica ou suspeita de complicação (AAP, 2014).
Exames de sangue	Não são rotina. Considerados em casos graves ou com suspeita de infecção bacteriana.

2.4 Sinais de gravidade e critérios de internação (SBP, 2017)

- Episódios de apneia (pausas na respiração).
- Piora do estado geral: hipoativo, prostrado, acorda apenas com estímulos prolongados.
- Desconforto respiratório: gemência, retração torácica, FR acima de 60, cianose central, saturação abaixo de 92% persistente.
- Sinais de desidratação.
- Recusa alimentar, ingestão reduzida e/ou sem diurese por 12 horas.
- Comorbidades: displasia broncopulmonar, cardiopatia, imunodeficiência, doença neuromuscular.

Papel do técnico de enfermagem no diagnóstico: o técnico não faz o diagnóstico, mas é quem mais observa o paciente. Identificar e comunicar rapidamente esses sinais faz parte da avaliação contínua e pode mudar a conduta médica.

3. Tratamento (aprofundado)

3.1 Princípio

Não há terapêutica específica que abrevie o curso da doença: o tratamento é de suporte, e a maioria dos pacientes evolui bem (SBP, 2017). O objetivo é manter o bebê hidratado, com as vias aéreas desobstruídas e bem oxigenado enquanto o próprio organismo vence o vírus.

3.2 Como está no slide 12

O slide tem dois cards. **INDICADO ✓:** hidratação (amamentação e líquidos; se não aceitar, sonda ou veia); lavagem nasal com soro fisiológico antes das mamadas; oxigênio no hospital se SpO_2 abaixo de 90–92%; antitérmico se houver febre, conforme prescrição; em casa, nenhum remédio sem receita e voltar ao serviço se houver sinal de alarme. **NÃO INDICADO ×:** broncodilatador, corticoide, antibiótico e vaporizador/umidificador (névoa). As tabelas abaixo trazem o detalhe de cada item, para você responder se a banca perguntar.

Sobre nebulização: a nebulização é só a forma de administrar. Nebulizar broncodilatador ou adrenalina não é recomendado; a salina hipertônica 3% pode ser considerada no hospital, por decisão médica; o soro comum 0,9% nebulizado não tem recomendação.

3.3 O que a diretriz recomenda ou permite considerar

Medida	Como funciona / quando
Hidratação	Manter amamentação. Se não conseguir por via oral: sonda nasogástrica ou soro na veia (solução isotônica). Estudo com 759 lactentes não mostrou diferença entre sonda e veia; a sonda é mais acessível.
Higiene nasal	Soro fisiológico 0,9% antes das mamadas. Lavagem nasal sem aspiração já melhora a saturação.
Aspiração nasal	Suave e superficial, só quando necessária. Aspiração profunda ou repetida pode irritar a mucosa e prolongar a internação.
Oxigênio	Não indicado com SpO_2 acima de 90% sem acidose. Considerar entre 90 e 92%, especialmente com esforço respiratório e menores de 3 meses. Sempre conforme prescrição.
Salina hipertônica 3%	Pode ser considerada em internados (mais de 3 dias), por decisão médica, por nebulização.
Cânula nasal de alto fluxo	Pode ser considerada em casos mais graves, em ambiente hospitalar.
Antitérmico	Se necessário, conforme prescrição.

3.4 O que NÃO é recomendado (e por quê)

Tratamento	Motivo
Broncodilatador (ex.: salbutamol)	Estudos não mostraram melhora dos sintomas, da taxa de internação nem do tempo de internação. Na bronquiolite a obstrução é por edema e muco, não por contração do

	músculo como na asma.
Adrenalina	Sem benefício comprovado em pacientes ambulatoriais ou internados.
Corticoide	Ensaios grandes e multicêntricos sem benefício.
Antibiótico	A doença é viral; o uso rotineiro não reduz dias de sintomas, internação ou necessidade de O_2. Só se houver infecção bacteriana associada.
Fisioterapia respiratória de rotina	Não recomendada; reservada para casos com comorbidades.
Névoa (vaporizador / umidificador)	"Sem evidência de recomendação" (SBP, tabela de condutas).

3.5 Tratamento em casa (orientação aos cuidadores)

- Higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70%.
- Evitar fumaça de cigarro (tabagismo passivo).
- Manter alimentação e amamentação, oferecendo em volumes menores e mais vezes.
- Lavagem nasal com soro fisiológico, principalmente antes de mamar e dormir.
- Antitérmico apenas se necessário e prescrito; nenhum xarope ou remédio sem receita.
- Voltar imediatamente ao serviço se aparecer qualquer sinal de alarme.

3.6 Cuidados de enfermagem no paciente internado (parte da Celma)

- Monitorar FC, FR (1 minuto), SpO_2, temperatura e padrão respiratório; registrar com horário.
- Higiene nasal com SF 0,9% antes das mamadas; aspiração suave só se necessária; registrar aspecto e quantidade da secreção.
- Instalar e manter oxigênio conforme prescrição, checando a adaptação do dispositivo (cateter, máscara) e a umidificação.
- Controle de aceitação alimentar e balanço hídrico: pesar fraldas (1 g ≈ 1 mL de urina).
- Cabeceira elevada a 30°; agrupar os cuidados para o bebê descansar; ambiente tranquilo.
- Precaução de contato e gotículas; higiene das mãos nos 5 momentos.
- Orientar a mãe/acompanhante; comunicar imediatamente sinais de agravamento à enfermeira.

4. Anotação de enfermagem (parte da Celma, para apoio)

4.1 O que é e para que serve

É o registro escrito, feito pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, de tudo o que foi observado e realizado com o paciente. É um documento legal: comprova a assistência, garante a continuidade do cuidado entre os plantões e protege o profissional. O que não está anotado, para fins legais, não foi feito.

Diferença importante: a anotação de enfermagem (técnico/auxiliar) descreve dados observados e cuidados realizados. A evolução de enfermagem é privativa do enfermeiro e envolve análise e julgamento clínico.

4.2 Regras de ouro

- Sempre com **data e hora** de cada registro.
- Linguagem **objetiva**, clara, sem abreviações não padronizadas e sem julgamentos ("mãe nervosa" → "mãe chorosa, questiona sobre o estado do filho").
- Registrar **o que viu, o que fez e o resultado** (ex.: "realizada higiene nasal, com saída de secreção espessa em moderada quantidade").
- Não usar termos vagos como "bem", "normal", "sem alterações" sem descrever.
- Letra legível, caneta, **sem rasuras**, sem corretivo e sem deixar linhas em branco; se errar, escrever "digo" e continuar.
- Terminar com **nome completo, categoria e COREN**.
- Não registrar diagnóstico médico como se fosse conclusão própria; usar "com diagnóstico médico de...".

4.3 Roteiro (ordem sugerida)

Parte	O que escrever no caso de bronquiolite
Identificação	Data, hora, iniciais, idade, setor, leito, procedência, acompanhante.
Estado geral	Nível de consciência e atividade (ativo e reativo, choroso, hipoativo).
Respiratório	Padrão (taquipneico?), tiragem (onde, intensidade), batimento de asa de nariz, gemência, coriza, tosse, uso de O_2 (dispositivo e litros).
Sinais vitais	T, FC, FR, SpO_2 (em ar ambiente ou com O_2), PA; peso na admissão.
Procedimentos	Higiene nasal, aspiração (aspecto e quantidade), posicionamento, medicações administradas conforme prescrição.
Alimentação e eliminações	Aceitação das mamadas, vômitos, diurese (peso da fralda), evacuação.
Orientações e comunicação	O que foi orientado à mãe; a quem foi comunicada alguma alteração.
Assinatura	Nome, categoria, COREN.

4.4 Modelo 1 – Admissão (usado no slide)

02/11/2026, 14h30. Lactente M.H.S., 5 meses, admitido na enfermaria pediátrica, leito 08, procedente do PS pediátrico, acompanhado pela mãe, com diagnóstico médico de bronquiolite viral aguda. Encontra-se choroso, ativo e reativo. Apresenta coriza hialina, tosse produtiva e tiragem subcostal leve. SSVV: T 37,8 °C, FC 148 bpm, FR 56 irpm, SpO_2 93% em ar ambiente, PA 85/50 mmHg. Peso: 6,8 kg. Realizada higiene nasal com SF 0,9%, com saída de secreção espessa em moderada quantidade. Mantido em decúbito dorsal com cabeceira elevada a 30°. Instaladas precauções de contato e gotículas. Mãe

orientada quanto à higiene das mãos. Oferecido seio materno, com aceitação parcial. Diurese presente em fralda (45 g). Comunicado à enfermeira. Nome, Técnico(a) de Enfermagem, COREN-MG nº ____.

4.5 Modelo 2 – Intercorrência (piora)

02/11/2026, 20h10. Lactente apresentando aumento do esforço respiratório, com tiragem subcostal e intercostal moderada e batimento de asa de nariz. FR 68 irpm, FC 165 bpm, SpO_2 89% em ar ambiente. Realizada aspiração nasal suave, com saída de secreção espessa em grande quantidade. Mantido com cabeceira elevada a 30°. Comunicado imediatamente à enfermeira e ao médico plantonista. Instalado cateter nasal de O_2 a 1 L/min conforme prescrição. Após 15 minutos, SpO_2 95%. Mantido em observação. Nome, Técnico(a) de Enfermagem, COREN-MG nº ____.

Este segundo modelo é um exemplo didático para mostrar à banca como registrar uma piora: sinal observado → valor medido → ação → comunicação → resultado.

4.6 Siglas que aparecem na anotação

Sigla	Significado
SSVV	Sinais vitais
T	Temperatura (axilar)
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio
PA	Pressão arterial
SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%)
PS	Pronto-socorro
Coriza hialina	Secreção nasal clara, transparente
Ativo e reativo	Bebê se movimenta e responde a estímulos

5. Perguntas que a banca pode fazer

P: O que é a SBP e por que ela é a fonte do tratamento?

R: É a Sociedade Brasileira de Pediatria, entidade científica dos pediatras do Brasil. Ela analisa os estudos e publica diretrizes que orientam como diagnosticar e tratar. A diretriz de 2017 sobre o VSR é a referência oficial no país.

P: A nebulização ajuda?

R: Depende do que se nebuliza. Broncodilatador ou adrenalina nebulizados não são recomendados; vaporizador/umidificador também não. A salina hipertônica 3% pode ser considerada no hospital, por decisão médica.

P: Por que não se usa broncodilatador na bronquiolite?

R: Porque estudos não mostraram benefício. A obstrução é causada por edema, muco e restos celulares, e não por contração do músculo como na asma.

P: O raio-X é necessário para diagnosticar?

R: Não. O diagnóstico é clínico. O raio-X só é feito se houver dúvida ou suspeita de complicação.

P: Quando o bebê precisa de oxigênio?

R: Quando a saturação fica abaixo de 90 a 92%, conforme prescrição. Acima de 90% sem acidose, a SBP não recomenda.

P: Qual a diferença entre anotação e evolução de enfermagem?

R: A anotação é feita pelo técnico/auxiliar e registra o que foi observado e realizado. A evolução é privativa do enfermeiro e inclui análise e julgamento clínico.

P: Por que no caso do Miguel ele não está no oxigênio?

R: Porque a saturação dele é de 93% em ar ambiente, acima do ponto em que a diretriz indica O_2. Mas ele deve ser monitorado, pois pode piorar entre o 3º e o 5º dia.

P: Se você errar algo na anotação, o que faz?

R: Não rasura nem usa corretivo: escreve "digo" e corrige em seguida, mantendo o registro legível.

P: Como medir a diurese de um bebê?

R: Pesando a fralda usada e subtraindo o peso da fralda seca: cada grama corresponde a cerca de 1 mL de urina.

6. Checklist de revisão

- ☐ Explicar em uma frase o que é bronquiolite e o agente principal.
- ☐ Listar 6 sinais de alarme com os valores (FR acima de 60, SpO_2 abaixo de 92%).
- ☐ Explicar por que o diagnóstico é clínico e quando pedir raio-X.
- ☐ Saber 4 tratamentos recomendados e 4 não recomendados, com o motivo.
- ☐ Ler os dois modelos de anotação em voz alta sem tropeçar nas siglas.
- ☐ Saber a diferença entre anotação (técnico) e evolução (enfermeiro).

7. Glossário de siglas

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
VSR	Vírus Sincicial Respiratório	Principal vírus causador da bronquiolite (até 75% dos casos).
BVA	Bronquiolite Viral Aguda	Nome completo da doença.
SBP	Sociedade Brasileira de Pediatria	Entidade científica que reúne os pediatras do Brasil. Publica diretrizes, que são guias feitos a partir da análise de estudos científicos, para orientar médicos e equipes no diagnóstico e no tratamento. É a principal referência do trabalho: tudo o que dizemos sobre diagnóstico, tratamento, “indicado” e “não indicado” vem da diretriz da SBP de 2017.
AAP	American Academy of	Equivalente americana da SBP. A diretriz de

	Pediatrics (Academia Americana de Pediatria)	bronquiolite da AAP (2014) é usada no mundo todo e foi base para a diretriz brasileira.
SUS	Sistema Único de Saúde	Sistema público de saúde do Brasil.
SES-MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Gestão da saúde no estado. Compra e distribui vacinas e imunobiológicos para as regionais, acompanha os casos de SRAG e publica os dados de VSR do estado.
SRS	Superintendência Regional de Saúde (de Montes Claros)	"Braço" da SES-MG no Norte de Minas. Coordena 54 municípios: recebe as vacinas do estado e repassa para as cidades e maternidades.
SMS	Secretaria Municipal de Saúde (de Montes Claros)	Gestão da saúde na cidade: postos, hospitais conveniados, vigilância. É a autora do Relatório Anual de Gestão.
RAG	Relatório Anual de Gestão	Prestação de contas anual da SMS: mostra dados de saúde da cidade e se as metas foram cumpridas. Precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
CMS	Conselho Municipal de Saúde	Grupo formado por usuários, trabalhadores, prestadores e governo que fiscaliza a saúde do município. Aprovou o RAG 2025 em 25/02/2026.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS	Órgão do Ministério da Saúde que guarda os bancos de dados oficiais do SUS (internações, óbitos, nascimentos).
TabNet	Ferramenta de tabulação do DATASUS	Site onde qualquer pessoa monta tabelas com os dados do SUS, escolhendo ano, local, idade e doença.
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	Banco que registra todas as internações pagas pelo SUS. De onde vêm os números de internação da apresentação.
AIH	Autorização de Internação Hospitalar	Documento que o hospital preenche para o SUS pagar a internação. Cada AIH conta como uma internação no SIH.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão	Código padronizado de cada doença. J20 = bronquite aguda; J21 = bronquiolite aguda.
SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave	Quadro respiratório grave que leva à internação (febre, tosse, falta de ar, saturação baixa). Toda SRAG internada deve ser notificada, no SUS e na rede particular.
SIVEP-Gripe	Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe	Sistema onde os hospitais (públicos e particulares) notificam os casos de SRAG e o vírus encontrado no exame.
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz	Instituição de pesquisa do Ministério da Saúde.
InfoGripe	Boletim da Fiocruz	Analisa os dados do SIVEP-Gripe e mostra

		se os casos de SRAG estão subindo ou caindo em cada estado.
Unidade Sentinela	Serviço de vigilância de síndrome gripal	Unidade que coleta amostras de pacientes com síndrome gripal e envia para análise, para saber quais vírus estão circulando (VSR, influenza, COVID-19).
PNI	Programa Nacional de Imunizações	Programa do Ministério da Saúde que define o calendário de vacinas do SUS.
SI-PNI	Sistema de Informação do PNI	Sistema onde são registradas as doses aplicadas. É ali que se vê a cobertura vacinal (porcentagem do público vacinado).
CRIE	Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais	Serviço do SUS que aplica vacinas e imunobiológicos especiais, que não ficam nos postos comuns, para grupos específicos (prematuros, cardiopatas, imunossuprimidos). Na regional de Montes Claros, recebeu 503 das 766 doses de nirsevimabe, para atender crianças de risco que já saíram da maternidade.
Conitec	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS	Comissão que avalia se um remédio ou vacina deve entrar no SUS. Recomendou o nirsevimabe e a vacina VSR para gestantes em 2025.
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão que autoriza o registro de remédios e vacinas no Brasil.
Nirsevimabe	Anticorpo monoclonal contra o VSR	Anticorpo “pronto”, aplicado em dose única no bebê de risco (imunização passiva). Não é vacina.
UTI	Unidade de Terapia Intensiva	Setor para pacientes graves.
PS	Pronto-Socorro	Atendimento de urgência.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Luvas, avental, máscara, óculos.
SSVV	Sinais vitais	Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e pressão arterial.
T	Temperatura (axilar)	—
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto	—
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto	—
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio	Medida pelo oxímetro de pulso. Abaixo de 92% persistente é sinal de alarme.
PA	Pressão arterial	—
O_2 / CO_2	Oxigênio / gás carbônico	—

SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%)	Usado na lavagem nasal.
SSH 3%	Solução salina hipertônica a 3%	Soro mais concentrado; pode ser nebulizado no hospital, por decisão médica.
COREN-MG	Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais	Órgão que registra e fiscaliza os profissionais de enfermagem. O número do COREN vai na assinatura da anotação.
IA	Inteligência artificial	—

8. Fontes

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – 2017**. Rio de Janeiro: SBP, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20277e-Diretrizes_VSR.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

RALSTON, S. L. *et al*. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. **Pediatrics**, Itasca, v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, nov. 2014. DOI: 10.1542/peds.2014-2742.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Contra a bronquiolite: regional de Montes Claros alinha com maternidades uso de imunobiológico em bebês e crianças**. Belo Horizonte: SES-MG, 10 fev. 2026. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/noticias/contra-a-bronquiolite-regional-de-montes-claros-alinha-com-maternidades-uso-de-imunobiologico-em-bebes-e-criancas/. Acesso em: 4 nov. 2026.